

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: DBD

1. Identificación del Instrumento

Título original	Disruptive Behavior Disorders Rating Scale (DBD)
Título español	Escala de Trastornos de Comportamiento Perturbador
Sigla	DBD
Autores originales	William E. Pelham, J. N. Stone et al.
Año original	1992
Adaptador español	Universidad Internacional de Florida (FIU)
Año adaptación	2005
Formato	Cuestionario para padres y profesores de 45 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El DBD fue creado para evaluar la sintomatología del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) y el Trastorno Disocial (TD) de acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-III-R y DSM-IV. Es un estándar en la evaluación de la infancia.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar los síntomas de conducta perturbadora y TDAH en la infancia.
Población	Niños y adolescentes (5 a 17 años).
Administración	Respondida por padres o profesores (aprox. 10 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 10 minutos.
Corrección	Suma de puntuaciones por subescalas basadas en el DSM.

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
TDAH - Inatención	Ítems 1 al 9	Evalúa problemas de distracción, desorganización y olvido en el niño.
TDAH - Hiperactividad/Impulsividad	Ítems 10 al 18	Mide la inquietud motora, hablar en exceso y la impulsividad conductual.
Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)	Ítems 19 al 26	Mide actitudes desafiantes, hostilidad, rabietas y desobediencia.
Trastorno Disocial (TD)	Ítems 27 al 45	Mide agresiones a personas o animales, mentiras, robos y destrucción de propiedad.

5. Sistema de Puntuación

Los informantes responden en una escala Likert de 4 puntos (0 = Para nada, 1 = Un poco, 2 = Bastante, 3 = Mucho). Las puntuaciones se calculan sumando los ítems de cada subescala independiente.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Un ítem se considera clínicamente presente si es valorado con 'Bastante' (2) o 'Mucho' (3). El diagnóstico informal se asocia si el número de ítems presentes supera los criterios diagnósticos mínimos establecidos por el DSM para cada trastorno.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El DBD posee una gran consistencia interna (Alfa de Cronbach > 0.90 para las escalas principales) y una excelente validez convergente con evaluaciones clínicas estructuradas.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La versión oficial en español distribuida por el Center for Children and Families de la FIU es ampliamente utilizada en la investigación transcultural y la clínica infanto-juvenil.

9. Aplicaciones Prácticas

Psicología educativa, paidopsiquiatría, orientación escolar y clínica infanto-juvenil.

10. Fortalezas del Instrumento

- Diferencia con mucha claridad entre los subtipos de inatención e hiperactividad.
- Evaluación paralela (permite comparar la opinión del padre y del maestro).

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Sesgo subjetivo del informante (los profesores o padres pueden diferir en la tolerancia).

12. Consideraciones Éticas y Legales

No debe ser utilizado como diagnóstico definitivo de TDAH sin realizar exámenes médicos y neurológicos concurrentes.

13. Síntesis Técnica General

El DBD es un cuestionario de conducta infantil esencial para estimar la severidad de los trastornos disruptivos del comportamiento según el marco del DSM.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Pelham, W. E., et al. (1992). Teacher ratings of DSM-III-R disruptive behavior disorders. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 31(2), 210-218.